

Un lavoratore autistico nella vostra medicina del lavoro

Per l'infermieristica della medicina del lavoro e il personale sanitario aziendale — sostenere un adulto autistico impiegato.

L'idea chiave

L'autismo, attraverso il **monotropismo**, significa che l'attenzione di un adulto si chiude in pochi „tunnel” profondi e intensi. I luoghi di lavoro — open-space, rumorosi, pieni di interruzioni e regole non scritte — alimentano il masking e il **burnout autistico**, che è distinto dal comune stress occupazionale e dalla depressione. Come infermiere/a della medicina del lavoro siete ben posizionati per individuarlo, separarlo dalle questioni di performance e mediare i reasonable adjustments che tengono un lavoratore capace in salute e al lavoro.

Cosa potreste vedere — e cosa sta davvero accadendo

Potreste vedere...	Cosa spesso sta accadendo
Esausto, perde competenze, non si riprende dopo il lavoro	Burnout autistico — distinto dal burnout lavorativo e dalla depressione
„A posto” in ambulatorio, crolla per giorni dopo	Pesante masking ; una visita di 15 minuti raramente mostra il costo
Non segnala dolore, sintomi o effetti collaterali finché non sono gravi	Differenze di interocezione
Conflitti legati all'open-space, alle riunioni, allo hot-desking	Un problema di adattamento ambiente-persona, non di competenza
Vuole tutto per iscritto; evita le chiamate	La comunicazione su un solo canale riduce il carico

Provate questo

- **Offrite l'AHAT dell'AASPIRE** prima della visita e opzioni a **prima lo scritto**; permettete un accompagnatore.
- **Riconoscete il burnout autistico** e non confondetelo con la depressione o la „scarsa resilienza”.
- **Mediate i reasonable adjustments**: spazio quiete, istruzioni scritte, meno riunioni, comunicazione asincrona, aspettative definite.
- **Iniziate i farmaci a basso dosaggio e titolate lentamente** — risposte sensoriali/emotive atipiche sono comuni.
- **Documentate gli adattamenti efficaci** in modo che siano automatici la volta successiva.

Da evitare

- Lasciare che una visita calma e mascherata sovrasti l'autovalutazione e l'anamnesi.
- Trattare il burnout come depressione e spingere un piano di „ritorno al pieno carico”.
- Equiparare il „non lamentarsi” al „non soffrire”.

Quando chiedere altro supporto

Valutate la **suicidalità** — il burnout vi è collegato. Affrontate le condizioni co-occorrenti **ADHD (AuDHD), ansia, depressione, disturbi del sonno e gastrointestinali**. Se il burnout è grave, convalidate il rientro graduale, le ore ridotte o un cambio di ruolo come recupero, non come debolezza.

Se la lavoratrice è una donna

Le donne identificate tardi mascherano più di tutti; prendete sul serio un pattern lifelong di differenza e sovraccarico, anche con un'esterno „ad alta performance”.

Informazioni su questa guida

Con assistenza IA, derivata dalle bozze di ricerca del progetto — la guida **Pratici e sanità lungo l'arco di vita** (Parti 3.4 e 4) e la sintesi sul **Monotropismo**. Usa il linguaggio con l'identità per prima. **Informativa — non è consiglio medico né strumento diagnostico**. Adattatela alla singola persona.

Fonti chiave. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2023); Dwyer (2025); Raymaker et al. (2020); Mantzalas et al. (2022); Kelly Mahler (2024); AASPIRE AHAT. Le citazioni complete sono nelle bozze di fonte.